알부민뇨 동반 CKD 혈압·단백뇨·K·eGFR

ARB 기반 치료와 추가 약제의 효과·추적 항목을 함께 보기

ARB 기반 혈압·단백뇨 조절

↓

SGLT2 억제제 / 당뇨병성 CKD의 finerenone 추가

↓

혈압·단백뇨 효과 + K·eGFR·탈수 추적

본강 · RAS 억제제와 혈압

구분	진료 중 확인할 내용
치료의 근간	ARB는 혈압·사구체내압을 낮춰 단백뇨 감소. ACE 억제제/ARB를 기반으로 CCB 또는 신기능에 따른 이뇨제 병용 알고리즘을 소개.
혈압이 높지 않다면	Losartan 25 mg, 반 알 12.5 mg까지 응용 가능하다고 설명. 혈압 감소가 적은 ARB로 소개.
혈압 조절	연자는 ARB+CCB를 선호하며 고령·수분섭취 부족에서는 이뇨제에 의한 신전성 질소혈증을 주의. 목표를 130/80 mmHg 이하로 권유한다고 설명.

SGLT2 억제제·finerenone 추가

강의 알고리즘은 SGLT2 억제제 추가 또는 당뇨병성 콩팥병에서 finerenone 추가를 제시했습니다. Finerenone+empagliflozin 병합은 단독보다 단백뇨·혈압을 더 낮추지만 K 상승과 eGFR 감소를 함께 살펴야 한다고 강조했습니다.

추적 중 보는 세 축

혈압·단백뇨 · 약의 효과와 저혈압 증상을 함께 확인.

Serum K · Finerenone 사용 시 K 상승·부정맥 위험에 주의. 신기능이 나쁠수록, 특히 G4~G5에서 K 배설 능력 감소.

eGFR·수분 · SGLT2 억제제는 소변의 당과 함께 수분을 배출하여 탈수 상태를 만들 수 있음. 수분섭취·신기능을 관리.

저혈압·eGFR 감소 유지 여부를 판단할 조건

장재원 연자 Q&A · 수치만으로 단순화하지 않기

Finerenone 후 eGFR 감소 · 연자 Q&A

소량부터 사용하고 경과를 보며 증량을 고려한다고 답했습니다. 이론적으로 감소 <30%, 탈수 없음·신독성 약물 없음·전해질 정상이며 단백뇨가 의미 있게 감소했다면 현 용량 유지라고 설명했습니다. 다만 환자가 GFR 감소를 받아들이지 못하면 중단하라고 답했습니다.

혈압이 낮은 환자의 ARB · 연자 Q&A

BP <110/70 우려 질문에 기립성 저혈압·어지러움·피로감·두통이 없으면 이론적으로 복용 가능하나 Cr이 증가할 수 있어, 임상에서는 복용 전 혈압 측정 후 간헐적 중단을 설명한다고 답했습니다. 탈수·신기능 저하가 없고 전해질이 정상인 지속 사용은 코스카 0.5T를 제시했습니다.

SGLT2 억제제 · 연자 Q&A

구분	진료 중 확인할 내용
Empagliflozin 용량	GFR 30~45에서 25 mg 증량 질문: 사구체내압·단백뇨 감소 효과는 10 mg에서 최대이므로 25 mg으로 올릴 필요는 없다고 답변.
수분섭취 제한 고령자	85세·eGFR 35, 야간뇨 두려움으로 물을 제한하는 증례: 탈수·신기능 저하 가능성을 강조. 3~6개월마다 신기능·소변, 매년 신장방광초음파를 보며 보존적 관리가 가장 안전하다고 답변.

신전성 질소혈증의 감별 · 본강

BUN/Cr >20을 단서로 삼되 상부 GI 출혈·패혈증·steroid·갑상선항진증에서도 증가할 수 있습니다. CKD·이뇨제 사용 시 FeNa는 해석이 어렵고, 혈역학·수분 보충에 대한 반응이 진단에 도움이 된다고 설명했습니다.

추가 약제 처방과 안전한 추적의 범위

장재원 연자 Q&A · 적응 맥락·동의·검사·수분섭취를 함께 고려

Finerenone 조기 사용 질문 · 연자 Q&A

ARB·SGLT2 억제제에도 알부민뇨가 지속되는 당뇨병성 CKD에서, 질문자가 제시한 급여 범위는 eGFR 25 이상~75 미만입니다. eGFR ≥75 비보험 처방에 대해 환자가 동의하고 매 내원 BUN·Cr·전해질을 확인하여 악화가 없으면 빠른 시작이 도움이 된다고 답했습니다.

비당뇨 CKD의 SGLT2 억제제 질문 · 연자 Q&A

질문자는 급여 기준을 알부민뇨 200 mg 이상·eGFR <75로, 연구 범위를 알부민뇨 ≥200 mg에서 eGFR 20 이상~90 미만 또는 <200 mg에서 eGFR 20 이상~45 미만으로 제시했습니다. 연자는 범위를 일률 적용하면 수분섭취 부족에 따른 Cr 상승을 만날 수 있어 개인적으로 환자를 선별하며 주치의 판단에 따르도록 답했습니다.

본강 · K와 체액 상태

구분	진료 중 확인할 내용
고칼륨혈증	정상 K 3.5~5.1 mmol/L로 소개. 지속 상승 시 사지마비·호흡곤란·심장기능 이상 위험. 저염 소금·저염 간장·된장 등 칼륨 함유 대체품 주의.
수분·이뇨제	고령·수분섭취 부족에서 이뇨제·SGLT2 억제제 사용을 조심. 연자는 단백뇨 조절에 ARB+CCB를 선호한다고 설명.

본강 · 의뢰로 연결

구분	진료 중 확인할 내용
K·혈압	조절되지 않는 고칼륨혈증 또는 ≥4개 약제에도 조절 안 되는 고혈압.
신기능·단백뇨	갑작스러운 GFR 감소, G4~G5(안전하게 G3b부터), 치료에도 uPCR >1,000 mg/g이면 신장내과 의뢰.